Formularze monitorowania sytuacji

Wersja do wydruku i ręcznego wypełnienia

Formularz prosty

Opisuj jedno zdarzenie. Przy informacjach rozróżniaj: O — własna obserwacja, P — przekaz osoby (także AAC), R — relacja innej osoby, H — hipoteza. Przy opisach etapów zaznacz źródła w checkboxach; możesz wybrać kilka. Doprecyzowanie jest opcjonalne. Brak danych nie oznacza braku trudności. Zapis wykonaj, gdy pozwala na to bezpieczeństwo.

Dane podstawowe

Data ..... **Godzina** ..... **Miejsce** .....

Oznaczenie osoby ..... **Osoba sporządzająca zapis** .....

Inne osoby obecne

.....

Początek i koniec obserwacji

.....

Środowisko

☐ Dom ☐ Szkoła

☐ Ośrodek ☐ Inne: .....

Szybki opis sytuacji

Jak wyglądał stan osoby przed sytuacją?

Sen, głód, ból, hałas, zmiany planu, wcześniejsze napięcie.

Co działo się bezpośrednio przed sytuacją?

Opisz ostatnie minuty: wymaganie, zmianę, odmowę, czekanie, kontakt.

Pierwsze sygnały narastającego napięcia

Co pojawiło się zanim sytuacja się nasiliła: ciało, głos, ruch, wycofanie.

Źródła tego opisu — Pierwsze sygnały

☐ O — własna obserwacja ☐ P — przekaz osoby (także AAC) ☐ R — relacja innej osoby ☐ H — hipoteza

Doprecyzowanie źródeł (opcjonalnie) — Pierwsze sygnały

.....

Jak zareagowało otoczenie na pierwsze sygnały trudności? Co osoba zrobiła lub zakomunikowała po tej reakcji?

Uwzględnij obserwacje i informacje przekazane przez osobę. Jeśli trudno ocenić — zaznacz to.

Źródła tego opisu — Eskalacja
☐ O — własna obserwacja ☐ P — przekaz osoby (także AAC) ☐ R — relacja innej osoby ☐ H — hipoteza

Doprecyzowanie źródeł (opcjonalnie) — Eskalacja

.....

Jak przebiegała eskalacja? Jakie działania lub zmiany towarzyszyły jej nasilaniu się i ustępowaniu?
Uwzględnij obserwacje i informacje przekazane przez osobę. Jeśli trudno ocenić — zaznacz to.

Źródła tego opisu — Po eskalacji
☐ O — własna obserwacja ☐ P — przekaz osoby (także AAC) ☐ R — relacja innej osoby ☐ H — hipoteza

Doprecyzowanie źródeł (opcjonalnie) — Po eskalacji

.....

Czego osoba potrzebowała przed ponownym kontaktem lub aktywnością? Co jej zapewniono i po czym rozpoznano gotowość?
Uwzględnij obserwacje i informacje przekazane przez osobę. Jeśli trudno ocenić — zaznacz to.

Czy osoba miała wpływ, wybór, możliwość negocjacji lub przerwy?
Co osoba mogła kontrolować, a co było narzucone lub nieuniknione?

Czy sytuacja była przewidywalna? Co było znane / nieznane?
Czy było wiadomo, co się wydarzy, jak długo potrwa i jaki będzie koniec?

Czas do zaobserwowania gotowości
Po ilu minutach od zakończenia opisanego zachowania zaobserwowano oznaki gotowości? Możesz podać godzinę. Zaznacz szacunek / brak danych / nie zaobserwowano do końca obserwacji. Potrzeby i oznaki gotowości opisz przy etapie po eskalacji.

Formularz rozszerzony

Jeden zapis dotyczy jednego zdarzenia. O — obserwacja, P — przekaz osoby, R — relacja innej osoby, H — hipoteza. Przy opisach etapów zaznacz źródła w checkboxach; możesz wybrać kilka. Doprecyzowanie jest opcjonalne. Podaj, od kiedy obserwowałaś/obserwowałeś. Nie musisz wypełniać pól, których nie da się ocenić — wpisz „brak danych".

Dane podstawowe

Data ..... **Godzina** ..... **Miejsce** .....

Oznaczenie osoby ..... **Osoba sporządzająca zapis** .....

Inne osoby obecne

.....

Początek i koniec obserwacji

.....

Środowisko

☐ Dom ☐ Szkoła
☐ Ośrodek ☐ Inne: .....

0. Poziom bazowy i kontekst dnia

Poziom napięcia przed zdarzeniem

Ocena obserwatora, nie skala diagnostyczna. Dopisz konkretne oznaki i porównaj ze zwykłym funkcjonowaniem osoby; jeśli nie wiesz, pomiń ocenę.

☐ 0 niski / stabilny ☐ 1 podwyższony
☐ 2 wysoki ☐ 3 bardzo wysoki

Oznaki będące podstawą oceny napięcia

.....

Czy osoba była zmęczona?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Czy osoba spała wystarczająco?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Informacje o śnie i ich źródło — jeśli są dostępne

Np. krótki sen, pobudki, koszmary, bardzo wczesna pobudka.

.....

Etap pobytu / kontekst dnia, jeśli dotyczy

☐ dzień przyjazdu / zmiany ☐ dzień wyjazdu / powrotu
☐ środek tygodnia ☐ koniec tygodnia
☐ nie dotyczy

Czy etap był obciążający? — placówka całodobowa, jeśli dotyczy

☐ Tak ☐ Nie
☐ Nie wiem ☐ Nie dotyczy

Czynniki obciążające

☐ słaby sen / pobudka w nocy ☐ zmiana planu
☐ wyjście / powrót / podróż ☐ wizyta gości / większa liczba osób
☐ konflikt ☐ presja czasu
☐ hałas / tłok ☐ ból / dyskomfort
☐ głód / pragnienie ☐ inne: .....

Stan ciała

☐ głód ☐ pragnienie
☐ potrzeba toalety ☐ ból / dyskomfort
☐ zmęczenie fizyczne ☐ temperatura ciała — zimno/gorąco
☐ napięcie mięśniowe ☐ inne: .....

Intensywność sensoryczna

☐ hałas / dźwięki ☐ światło
☐ tłok / liczba osób ☐ zapachy
☐ tekstury / dotyk ☐ temperatura pomieszczenia
☐ inne: .....

1. Bezpośrednio przed zdarzeniem

Co wydarzyło się bezpośrednio przed zdarzeniem?

☐ zmiana aktywności
☐ czekanie
☐ prośba / polecenie
☐ kontakt społeczny
☐ konflikt
☐ inne: .....
☐ koniec aktywności
☐ odmowa / brak dostępu
☐ korekta zachowania
☐ hałas / tłok
☐ przejście między miejscami

Doprecyzowanie tego, co było bezpośrednio przed

Opisz fakty obserwowalne, bez oceniania i przypisywania winy.

2. Czego oczekiwano w tym momencie?

Na co osoba miała wpływ?

Wybór kolejności, czasu, miejsca, sposobu wykonania, możliwość przerwy.

Co było nieznane, narzucone albo poza wpływem?

Nagła zmiana, brak informacji, presja czasu, brak możliwości odmowy lub negocjacji.

Czy było wiadomo, co się wydarzy?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Czy było wiadomo, jak długo to potrwa?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Czy była możliwość negocjacji lub wyboru?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Oczekiwania / wymagania

☐ brak wymagań
☐ rozpoczęcie zadania
☐ czekanie
☐ podporządkowanie się zasadzie
☐ inne: .....
☐ koniec aktywności
☐ przejście do innego miejsca
☐ kontakt społeczny
☐ wykonanie czynności samoobsługowej

3. Pierwsze oznaki narastającego napięcia

Czy pojawiły się sygnały?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Ile czasu przed eskalacją?

Szacunkowo: minuty, kilkanaście minut, wcześniej w ciągu dnia.

.....

Obserwowane zmiany ciała i ruchu

☐ przyspieszone oddychanie
☐ pot
☐ rozszerzone źrenice
☐ inne: .....
☐ napięcie mięśniowe
☐ drżenie
☐ ucieczka / walka

Obserwowane ograniczenie kontaktu lub aktywności

☐ patrzenie w jeden punkt / podłogę
☐ spowolnienie ruchów
☐ wycofanie
☐ brak reakcji na głos
☐ opadnięcie ciała
☐ inne: .....

Obserwowane reakcje na otoczenie

☐ zatykanie uszu
☐ stereotypie
☐ ucieczka z pomieszczenia
☐ zasłanianie oczu
☐ unikanie dotyku
☐ inne: .....

Źródła tego opisu — Pierwsze sygnały
☐ O — własna obserwacja ☐ P — przekaz osoby (także AAC) ☐ R — relacja innej osoby ☐ H — hipoteza

Doprecyzowanie źródeł (opcjonalnie) — Pierwsze sygnały

.....

Jak zareagowało otoczenie na pierwsze sygnały trudności? Co osoba zrobiła lub zakomunikowała po tej reakcji?
Uwzględnij obserwacje i informacje przekazane przez osobę. Jeśli trudno ocenić — zaznacz to.

Co zwykle pojawia się najpierw?
Pierwszy najmniejszy sygnał, który może pomóc zareagować wcześniej.

.....

Czy w innych zapisach te sygnały poprzedzały opisane zachowanie?
☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

3B. Kontynuowanie aktywności, kompensacja i możliwe maskowanie

Co obserwowano podczas kontynuowania aktywności?
Zapisz działania, dostępne wsparcie i czas. Samo kontynuowanie nie dowodzi przeciążenia ani maskowania. Możliwe: nie dotyczy / brak danych.

Co osoba przekazała o wysiłku lub dyskomforcie?
Przekaz osoby (P), także AAC. Brak komunikatu nie oznacza braku doświadczenia.

Co zauważono później?
Oddziel własną obserwację (O) od relacji innych (R); podaj czas i źródło.

Czy rozważamy kompensację lub maskowanie — na jakiej podstawie?
Hipoteza (H), nie rozpoznanie. Możliwe: brak podstaw do oceny.

4. Udzielone wsparcie i warunki jego udzielenia

Podjęte działania
☐ obniżenie bodźców sensorycznych
☐ zapewnienie przewidywalności
☐ czas bez wymagań / pauza
☐ inne: .....
☐ zwiększenie autonomii / wybór
☐ wsparcie interoceptywne
☐ regulacja sensoryczna

Czy dostęp do wsparcia uzależniono od wykonania polecenia?
☐ Tak ☐ Nie ☐ Częściowo ☐ Nie wiem

Czy użyto regulatora / strategii regulacyjnej?
☐ Tak
☐ Częściowo
☐ Nie
☐ Nie wiem

5. Opis zachowania

Źródła tego opisu — Eskalacja
☐ O — własna obserwacja ☐ P — przekaz osoby (także AAC) ☐ R — relacja innej osoby ☐ H — hipoteza

Doprecyzowanie źródeł (opcjonalnie) — Eskalacja

.....

Jak przebiegała eskalacja? Jakie działania lub zmiany towarzyszyły jej nasilaniu się i ustępowaniu?
Uwzględnij obserwacje i informacje przekazane przez osobę. Jeśli trudno ocenić — zaznacz to.

Nasilenie opisanego zachowania
Podaj liczbę, czas lub cechę działania, którą można porównywać. Np. 3 uderzenia dłonią w stół. Nie oceniaj całego zdarzenia skalą agresji.

.....

Skutki / szkody zaobserwowane
☐ nie zaobserwowano szkód
☐ uraz innej osoby
☐ przerwanie aktywności
☐ inne: .....
☐ uraz osoby
☐ uszkodzenie rzeczy
☐ brak danych

Opis faktycznych skutków

.....

Potencjalne zagrożenie — oddzielnie od skutków
Co było możliwym zagrożeniem lub czemu zapobieżono? Nie zapisuj tego jako skutku, który faktycznie nastąpił.

.....

6. Czas i gotowość

Czas trwania opisanego zachowania
Podaj początek i koniec zachowania oraz czas trwania. Zaznacz szacunek / brak danych / trwało do końca obserwacji.

Zmniejszenie obserwowanych oznak napięcia
Jakie oznaki się zmniejszyły? Po ilu minutach od rozpoczęcia opisanego zachowania to zaobserwowano? Podaj minuty lub godzinę. Możliwe: nie zaobserwowano do końca obserwacji / brak danych.

Czas do zaobserwowania gotowości
Po ilu minutach od zakończenia opisanego zachowania zaobserwowano oznaki gotowości? Możesz podać godzinę. Zaznacz szacunek / brak danych / nie zaobserwowano do końca obserwacji. Potrzeby i oznaki gotowości opisz w części „Po eskalacji”.

7. Po eskalacji

Źródła tego opisu — Po eskalacji
☐ O — własna obserwacja ☐ P — przekaz osoby (także AAC) ☐ R — relacja innej osoby ☐ H — hipoteza

Doprecyzowanie źródeł (opcjonalnie) — Po eskalacji

.....

Czego osoba potrzebowała przed ponownym kontaktem lub aktywnością? Co jej zapewniono i po czym rozpoznano gotowość?
Uwzględnij obserwacje i informacje przekazane przez osobę. Jeśli trudno ocenić — zaznacz to.

Co wydarzyło się po zdarzeniu?
☐ przejście do spokojniejszego miejsca
☐ odpoczynek
☐ rozmowa później
☐ powrót do aktywności
☐ sen
☐ kontakt z bliską osobą
☐ brak dalszych wymagań
☐ inne: .....

Czy podczas tego zdarzenia była interwencja fizyczna?
☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Jeśli tak — ile razy?
Wpisz liczbę lub przybliżenie.

.....

Czy osoba reagowała szybciej lub mocniej niż zwykle?
☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Działanie, kontekst i następstwa interwencji fizycznej / bezpieczeństwo
Co zrobiono, jakie były skutki i dalsze potrzeby bezpieczeństwa? Bez instrukcji technik fizycznych.

.....

Mapa środowiska

Okres obserwacji uwzględniony w mapie

.....

Data aktualizacji mapy

.....

Zaznacz źródło: O — obserwacja, P — przekaz osoby, R — relacja innej osoby, H — hipoteza. Mapa opisuje aktualną wiedzę, preferencje i przypuszczenia.

Dane podstawowe

Data ..... **Godzina** ..... **Miejsce** .....

Oznaczenie osoby ..... **Osoba sporządzająca zapis** .....

Inne osoby obecne

.....

Początek i koniec obserwacji

.....

Środowisko

☐ Dom ☐ Szkoła
☐ Ośrodek ☐ Inne: .....

1. Miejsca i preferowane przestrzenie

Gdzie osobie jest najłatwiej?

☐ pokój osoby ☐ salon / wspólna przestrzeń
☐ kuchnia / jadalnia ☐ łazienka
☐ przedpokój / przejścia ☐ na zewnątrz
☐ samochód ☐ inne: .....

Co obserwujesz w tych miejscach i co mówi o nich osoba?

Co tam działa: cisza, światło, kontrola bodźców, przewidywalność, osoba towarzysząca.

Jakich miejsc osoba unika albo gdzie jest trudniej?

☐ pokój osoby ☐ salon / wspólna przestrzeń
☐ kuchnia / jadalnia ☐ łazienka
☐ przedpokój / przejścia ☐ na zewnątrz
☐ samochód ☐ inne: .....

Co obserwujesz w tych miejscach i co może utrudniać sytuację?

Co obciąża: hałas, zapachy, tłok, przejścia, oczekiwanie, brak wpływu.

2. Aktywności, role i relacje

Co osoba lubi robić lub wybiera?

Aktywności, tematy, relacje, miejsca lub rytuały, które odbudowują zasoby.

Jaka rola w aktywności jest najłatwiejsza?

☐ prowadzący / kontrolujący ☐ uczestnik współpracujący
☐ obserwator / obecność bez aktywnego udziału ☐ samodzielnie bez interakcji z innymi

3. Warunki optymalnego funkcjonowania

Osobie jest najłatwiej, gdy...

- ☐ jest cisza / mało bodźców słuchowych
- ☐ otoczenie jest spokojne
- ☐ ma samotność / czas bez wymagań
- ☐ kontakt jest 1:1
- ☐ ma wpływ na przebieg aktywności
- ☐ może negocjować lub wybierać
- ☐ jest najedzona / napita
- ☐ temperatura jest komfortowa
- ☐ inne: .....
- ☐ światło jest przyciemnione / naturalne
- ☐ może kontrolować bodźce
- ☐ jest bliska osoba bez wymagań
- ☐ kontakt może być równoległy, bez bezpośredniej komunikacji
- ☐ wie, co się wydarzy i jak długo potrwa
- ☐ są rutyny / powtarzalność
- ☐ jest wypoczęta
- ☐ nie ma bólu / dyskomfortu

4. Wsparcie i regulatory

Z kim osoba wybiera kontakt? Jak ten kontakt przebiega?

Zwróć uwagę na styl kontaktu tej osoby: ton, dystans, brak presji, przewidywalność.

Co zmniejsza napięcie?

- ☐ cisza / wyciszenie bodźców
- ☐ ciężar / ucisk
- ☐ stereotypie / bujanie / skakanie
- ☐ sen / drzemka
- ☐ obecność bliskiej osoby bez wymagań
- ☐ kontakt fizyczny
- ☐ wycofanie wymagania
- ☐ wybór / możliwość decyzji
- ☐ inne: .....
- ☐ ruch — huśtawka / trampolina / spacer
- ☐ chłód lub ciepło
- ☐ jedzenie / picie
- ☐ toaleta
- ☐ samotność / wycofanie
- ☐ dystans / przestrzeń osobista
- ☐ dostęp do ulubionej aktywności
- ☐ informacja, ile to potrwa

Co daje energię / pomaga odbudować zasoby?

Nie tylko co uspokaja, ale co realnie regeneruje po obciążeniu.

5. Od czego zależy funkcjonowanie?

W jakich warunkach obserwujesz różnice zachowania lub gotowości?

- ☐ hałas
- ☐ zmiana planu
- ☐ sen
- ☐ ból / dyskomfort
- ☐ kontakt społeczny
- ☐ oczekiwanie
- ☐ inne: .....
- ☐ liczba osób
- ☐ pora dnia
- ☐ jedzenie / picie
- ☐ temperatura
- ☐ presja czasu
- ☐ przejścia między aktywnościami

Jak zmienia się zachowanie w zależności od tych warunków?

Opisz różnice: kiedy jest łatwiej, kiedy szybciej narasta napięcie, co obniża próg reakcji.

6. Bezpieczne przestrzenie i osoby

Gdzie / przy kim osoba może wracać do regulacji bez dodatkowych wymagań?

Bez rozmowy naprawczej, pytań i nowych poleceń, z uwzględnieniem komunikowanych potrzeb i obserwowanych oznak gotowości.

7. Konteksty eskalacji i profilaktyka

Kiedy najczęściej rośnie ryzyko eskalacji?

☐ oczekiwanie / czekanie
☐ zmiana planu
☐ kontakt społeczny
☐ brak wpływu
☐ zmęczenie / głód / ból
☐ koniec aktywności
☐ hałas / tłok
☐ korekta zachowania
☐ przejście do innego miejsca
☐ inne: .....

Co może zmniejszyć ryzyko eskalacji?

☐ uprzedzenie / przygotowanie
☐ wybór kiedy / jak / w jakiej kolejności
☐ jasny koniec
☐ obecność bliskiej osoby
☐ inne: .....
☐ timer / plan wizualny
☐ negocjacja / omówienie
☐ brak pośpiechu
☐ dostęp do regulacji sensorycznej

Czy podobne sytuacje zdarzają się bez opisywanej eskalacji?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Jeśli tak — co jest podobne, a co inne? Co może pomagać?

To mogą być warunki ochronne: osoba, miejsce, przewidywalność, wybór, brak presji.

Bibliografia towarzysząca formularzom

Poniższe pozycje przeniesiono z instrukcji Małgorzaty Mikołajczyk „Jak korzystać z formularzy monitorowania", z sekcji „Podstawa merytoryczna". Stanowią bibliografię towarzyszącą formularzom, nie potwierdzenie walidacji narzędzia ani trafności każdej jego kategorii.

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2020). *Applied Behavior Analysis* (3rd ed.). Pearson.

O'Neill, R. E., Albin, R. W., Storey, K., Horner, R. H., & Sprague, J. R. (2015). *Functional Assessment and Program Development for Problem Behavior: A Practical Handbook* (3rd ed.). Cengage Learning.

Garfinkel, S. N., Seth, A. K., Barrett, A. B., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2015). Knowing your own heart: Distinguishing interoceptive accuracy from interoceptive sensibility. *Biological Psychology*, 104, 65–74.

Shah, P., Hall, R., Catmur, C., & Bird, G. (2016). Alexithymia, not autism, is associated with impaired interoception. *Cortex*, 81, 215–220.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „what" and „why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

O'Nions, E., Christie, P., Gould, J., Viding, E., & Happé, F. (2014). Development of the „Extreme Demand Avoidance Questionnaire" (EDA-Q): Preliminary observations on a trait measure for pathological demand avoidance. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(7), 758–768.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2014). *SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach*. HHS Publication No. SMA 14-4884.